Relatório de fidelidade

Situs fetal • Posição cardíaca

Gerado em 19/10/2026 — ApostilaIA 1.0.0, processamento 100% local
Transcrição aula_parte1.txt, aula_parte2.txt (5283 palavras, 00:35:00 de aula)
Slides AULA 01 - Situs.pdf, AULA 02 - Posição.pdf
Perfil Equilibrada — 898 palavras, 11 páginas no PDF
Modelos Simulador (testes)
Aceleração CPU (simulador de testes)
Tempo 0.0 min

1. Verificações da auditoria

Nº	Verificação	Resultado	
1	Principais assuntos da aula preservados	6/6 trechos com cobertura ≥ 60%	✓ ok
2	Exemplos importantes presentes	5/5 exemplos identificados na apostila	✓ ok
3	Observações clínicas incluídas	60/60 observações/dicas/alertas; 0 reinseridas pela auditoria	✓ ok
4	Sem informações externas	1 frase(s) sem suporte removida(s); 0 parcial(is) para conferência; 1 número(s) sem fonte	! revisar
5	Slides corretamente associados	5 slides associados à fala, 8 por posição, 0 sem associação; 0 trecho(s) da fala sem slide correspondente (não forçado)	✓ ok
6	Sem parágrafos duplicados	129 duplicata(s) removida(s)	✓ ok
7	Português	0 marca(s) de oralidade restante(s); 0 frase(s) muito longa(s)	✓ ok
8	Tabelas e figuras legíveis	1 tabela(s) (0 com 6 colunas), 4 figura(s) em 160 dpi	✓ ok
9	Esquemas fiéis às fontes	0 esquema(s); 0 descartado(s) por falta de sustentação	✓ ok
10	Objetiva e agradável para estudo	898 palavras (referência do perfil: ~1584; fala: 5283 palavras)	✓ ok

2. Mapa da apostila (referências internas)

Cada capítulo com os trechos da transcrição (parte e parágrafo §) e os slides usados.

Cap.	Título	Transcrição	Slides
1	Situs solitus	Parte 1, §1 a Parte 1, §94	Situs fetal: slides 2, 4–8; Posição cardíaca: slides 3
2	Sequência de avaliação	Parte 2, §1 a Parte 2, §78	Posição cardíaca: slides 3–7

3. Divergências entre fala e slides

Valores diferentes para o mesmo assunto. A apostila não escolheu um deles por suposição: confira na aula.

Assunto	Na fala	No slide	Onde
cava inferior interrupcao veia	90%	59–75%	Parte 1, §22, Parte 1, §37, Parte 1, §52, Parte 1, §82; Situs fetal slide 5

4. Termos

Corrigidos com base na grafia dos slides

Nenhum.

Ambíguos — não corrigidos (conferir)

Nenhum.

5. Conteúdo sem sustentação nas fontes

Removido da apostila

Cap.	Frase	Motivo
1	Segundo diretrizes internacionais recentes, recomenda-se repetir o exame com ressonância magnética fetal em 97% dos casos.	termos ausentes das fontes

Parcialmente sustentado (mantido; conferir)

Nenhum.

Números sem correspondência nas fontes

Cap.	Frase	Número
1	Segundo diretrizes internacionais recentes, recomenda-se repetir o exame com ressonância magnética fetal em 97% dos casos.	97%

6. Possíveis omissões

Itens relevantes da fala com pouca correspondência no texto final (comparação automática por vocabulário; confira). *Nenhuma omissão relevante detectada.*

Repetições removidas

Cap.	Trecho	Repetia o cap.
1	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. bom, pessoal, vamos começar falando do sítios solitus, que é o arranjo habitual dos órgãos. O átrio morfologicamente direito fica à direita e o estômago fica à esquerda, (revisão	1
1	Vejam bem, uma coisa importante: o eixo cardíaco normal fica entre 25 e 65 graus.	1
1	Se o eixo estiver fora disso, a gente tem que olhar, com mais cuidado, porque isso pode indicar alguma alteração.	1
1	É uma dica que facilita muito o exame no dia a dia.	1
1	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. já o sítios inversus é a imagem em espelho do sítios solitus. Então o estômago vai estar à direita e, o átrio morfologicamente direito vai estar à esquerda.	1
1	Esse é um erro frequente: se você não conferir a posição fetal antes, pode achar que é inversus quando não é.	1
1	Vejam bem, no sítios ambíguo a gente fala de isomerismo., No isomerismo direito geralmente tem asplenia, e no isomerismo esquerdo tem poliesplenia.	1
1	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. a interrupção da veia cava inferior no isomerismo esquerdo acontece em 90% dos casos, então quando você vê a continuação pela ázigos, pensa em isomerismo esquerdo.	1
1	Vejam bem, por exemplo, teve um caso que eu atendi de uma gestante de 22 semanas em que a primeira pista foi justamente, a ázigos dilatada ao lado da aorta.	1
1	Vejam bem, uma coisa importante: o eixo cardíaco normal fica entre 25 e 65 graus.	1
1	Se o eixo estiver fora disso, a gente tem que olhar com mais cuidado, porque isso pode indicar alguma alteração.	1
1	É uma dica que facilita muito o exame no dia a dia.	1
1	Voltando ao que eu falei antes, já o sítios inversus é a imagem em espelho do sítios solitus. Então o estômago vai estar à direita e o átrio, morfologicamente direito vai estar à esquerda.	1
1	Voltando ao que eu falei antes, cuidado para não confundir com erro de lateralidade, do transdutor.	1
1	Esse é um erro frequente: se você não conferir a posição fetal antes, pode achar que é inversus quando não é.	1

Cap.	Trecho	Repetia o cap.
1	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. no sítios ambíguo a gente fala de isomerismo. No isomerismo direito geralmente tem asplenia, e no isomerismo esquerdo tem poliesplenia.	1
1	Voltando ao que eu falei antes, a interrupção da veia cava inferior no isomerismo esquerdo acontece em 90% dos casos, então quando você vê a continuação pela ázigos, pensa em isomerismo esquerdo.	1
1	Vejam bem, por exemplo, teve um caso que eu atendi de uma gestante de 22, semanas em que a primeira pista foi justamente a ázigos dilatada ao lado da aorta.	1
1	Voltando ao que eu falei antes, agora vamos diferenciar destroposição de destrocardia. Na dextroposição o coração está deslocado, para a direita, mas o ápice continua apontando para a esquerda.	1
1	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. as causas de dextroposição que a gente mais vê são hérnia diafragmática e derrame, pleural, que empurram o coração.	1
1	Vejam bem, então a sequência que eu ensino é: primeiro o situs, depois a posição cardíaca, em seguida as conexões venosas, depois as conexões atrioventriculares e por último as conexões ventriculoarteriais.	1
1	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. bom, pessoal, vamos começar falando do sítios solitus, que é o arranjo habitual dos órgãos. O átrio morfologicamente, direito fica à direita e o estômago fica à esquerda, (revisã	1
1	Vejam bem, uma coisa importante: o eixo cardíaco normal fica entre 25 e 65 graus.	1
1	Se o eixo estiver fora disso, a gente tem que olhar com mais cuidado, porque isso pode indicar alguma alteração.	1
1	Voltando ao que eu falei antes, na prática eu, sempre começo identificando o estômago, depois a posição do coração.	1
1	É uma dica que facilita muito o exame no dia a dia.	1
1	Esse é, um erro frequente: se você não conferir a posição fetal antes, pode achar que é inversus quando não é.	1
1	Voltando ao que eu falei antes, no sítios ambíguo a gente fala de isomerismo. No isomerismo direito geralmente tem asplenia, e no isomerismo esquerdo tem poliesplenia.	1
1	Voltando ao que eu falei antes, a interrupção da veia cava, inferior no isomerismo esquerdo acontece em 90% dos casos, então quando você vê a continuação pela ázigos, pensa em isomerismo esquerdo.	1
1	Vejam bem, por exemplo, teve um caso que eu atendi de uma gestante de 22 semanas em que a primeira pista foi justamente a ázigos dilatada ao lado da aorta.	1
1	Voltando ao que eu falei antes, bom, pessoal, vamos começar falando do sítios solitus, que é o arranjo habitual dos órgãos. O átrio morfologicamente direito fica à direita e, o estômago fica à esquerda, (revisão 5)	1
1	Se o eixo estiver fora disso, a gente tem que olhar com mais cuidado, porque isso pode indicar alguma alteração.	1
1	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: na prática eu sempre começo identificando o estômago, depois a posição do coração.	1
1	É uma, dica que facilita muito o exame no dia a dia.	1
1	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. já o sítios inversus é a imagem em espelho do sítios solitus. Então, o estômago vai estar à direita e o átrio morfologicamente direito vai estar à esquerda.	1
1	Esse é um erro frequente: se você não conferir a posição fetal antes, pode achar que é inversus quando não é.	1
1	Voltando ao que eu falei antes, no sítios ambíguo a gente fala de isomerismo. No isomerismo direito geralmente tem asplenia, e no isomerismo esquerdo tem poliesplenia.	1

Cap.	Trecho	Repetia o cap.
1	Vejam bem, a interrupção da veia cava inferior no isomerismo esquerdo acontece em 90% dos casos, então quando você vê a continuação pela ázigos, pensa em isomerismo esquerdo.	1
1	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. por exemplo, teve um caso que eu atendi de uma gestante de 22 semanas em que a primeira pista foi justamente a ázigos dilatada ao lado da aorta.	1
1	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. agora vamos diferenciar destroposição, de destrocardia. Na dextroposição o coração está deslocado para a direita, mas o ápice continua apontando para a esquerda.	1
1	Voltando ao que eu falei antes, na destrocardia o próprio ápice aponta para a direita. Então o, que define é para onde aponta o ápice.	1
1	Voltando ao que eu falei antes, as causas de dextroposição que a gente mais vê são hérnia diafragmática e derrame pleural, que empurram o coração.	1
1	Voltando ao que eu falei antes, então a sequência que eu ensino é: primeiro o situs, depois a posição, cardíaca, em seguida as conexões venosas, depois as conexões atrioventriculares e por último as conexões ventriculoar	1
1	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. se você seguir sempre essa ordem, você não esquece nenhuma etapa. É, o passo a passo da análise sequencial segmentar.	1
1	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: em alguns casos o bebê vai precisar do RASC logo depois do nascimento, que é a atriosseptostomia, para ampliar a comunicação interatrial.	1
1	Vejam bem, observem que isso muda o planejamento do parto, que, deve acontecer num centro com cardiologia pediátrica.	1
1	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. bom, pessoal, vamos começar falando do sítios solitus, que é o arranjo habitual dos órgãos. O átrio morfologicamente direito fica à direita e o estômago fica à esquerda, (revisão	1
1	Se o eixo estiver fora disso, a gente tem que olhar com mais cuidado, porque isso pode indicar alguma alteração.	1
1	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: na prática eu sempre começo identificando o estômago, depois a posição do coração.	1
1	É uma dica que facilita muito o exame, no dia a dia.	1
1	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. já o sítios inversus é a imagem em espelho do sítios solitus. Então o estômago vai estar à direita e o átrio morfologicamente direito vai estar à esquerda.	1
2	Agora vamos diferenciar destroposição de destrocardia. Na dextroposição o coração está deslocado para a direita, mas o ápice continua apontando para a esquerda.	1
2	Na destrocardia o próprio ápice aponta para a direita. Então o que define é para onde aponta o ápice.	1
2	As causas de dextroposição, que a gente mais vê são hérnia diafragmática e derrame pleural, que empurram o coração.	1
2	Então a sequência que eu ensino é: primeiro o situs, depois a posição cardíaca, em seguida as conexões venosas, depois as conexões atrioventriculares e por último as conexões ventriculoarteriais.	1
2	Se você seguir sempre essa ordem, você não esquece nenhuma etapa. É o passo a passo da análise sequencial segmentar.	1
2	Em alguns casos o bebê vai precisar do RASC logo depois do nascimento, que é a atriosseptostomia, para ampliar a comunicação interatrial.	1
2	Segundo diretrizes internacionais recentes, recomenda-se repetir o exame com ressonância magnética fetal em 97% dos casos.	1
2	Observem que isso muda o planejamento do parto, que deve acontecer num, centro com cardiologia pediátrica.	1

Cap.	Trecho	Repetia o cap.
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. agora vamos diferenciar destroposição de destrocardia. Na dextroposição o coração está deslocado para a direita, mas o ápice continua apontando para a esquerda.	1
2	Vejam bem, na destrocardia o próprio ápice aponta para a direita.	1
2	Voltando ao que eu falei antes, as causas de dextroposição que a gente mais vê são hérnia diafragmática e derrame pleural, que empurram o coração.	1
2	Vejam bem, então a sequência que eu ensino é: primeiro o situs, depois a posição cardíaca, em seguida as conexões venosas, depois as conexões atrioventriculares e por último as conexões ventriculoarteriais.	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: se você seguir sempre essa ordem, você não esquece nenhuma etapa. É o passo a passo da análise sequencial segmentar.	1
2	Voltando ao que eu falei antes, em alguns casos o bebê vai precisar do RASC logo depois do nascimento, que é a atriosseptostomia, para ampliar a comunicação interatrial.	1
2	Vejam bem, observem que isso muda o planejamento do parto, que deve acontecer num centro com cardiologia pediátrica.	1
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. agora vamos diferenciar destroposição de destrocardia. Na dextroposição o coração está deslocado para a direita, mas o ápice continua apontando para a esquerda.	1
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. na destrocardia o próprio ápice aponta para a direita. Então o que define é para onde aponta o ápice.	1
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. as causas de dextroposição que, a gente mais vê são hérnia diafragmática e derrame pleural, que empurram o coração.	1
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. então a sequência que eu ensino é: primeiro o situs, depois a posição cardíaca, em seguida as conexões venosas, depois as conexões atrioventriculares e por último as conexões ven	1
2	Voltando ao que eu falei antes, em alguns casos o bebê vai precisar do RASC logo depois do nascimento, que é a atriosseptostomia, para ampliar a comunicação interatrial.	1
2	Voltando ao que eu falei antes, observem que isso muda o planejamento do parto, que deve acontecer num centro com cardiologia pediátrica.	1
2	Então o que define é para onde aponta o ápice.	2
2	Vejam bem, na destrocardia o próprio ápice aponta para a direita.	1
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. as causas de dextroposição que a gente mais vê são hérnia diafragmática e derrame pleural, que empurram o coração.	1
2	Voltando ao que eu falei antes, então a sequência que eu ensino é: primeiro o situs, depois a posição cardíaca, em seguida as conexões, venosas, depois as conexões atrioventriculares e por último as conexões ventriculoar	1
2	É o passo a passo da análise sequencial segmentar.	2
2	Vejam bem, se você seguir sempre essa ordem, você não esquece nenhuma etapa.	2
2	Vejam bem, em alguns casos o bebê vai precisar do RASC logo depois do nascimento, que é a atriosseptostomia, para ampliar a comunicação interatrial.	1
2	Vejam bem, observem que isso muda o planejamento do parto, que deve acontecer, num centro com cardiologia pediátrica.	1
2	Voltando ao que eu falei antes, agora vamos diferenciar destroposição de destrocardia. Na dextroposição o coração está deslocado para a direita, mas o ápice continua apontando para a esquerda.	1
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. na destrocardia o próprio ápice aponta para a direita. Então o que define é para onde aponta o ápice.	1
2	Voltando ao que eu falei antes, as causas de dextroposição que a gente mais vê são hérnia diafragmática e derrame pleural, que empurram o coração.	1

Cap.	Trecho	Repetia o cap.
2	Vejam bem, então a sequência que eu ensino é: primeiro o situs, depois a posição cardíaca, em seguida as conexões venosas, depois as conexões atrioventriculares e por último as conexões ventriculoarteriais.	1
2	É o passo a, passo da análise sequencial segmentar.	2
2	Vejam bem, se você seguir sempre essa ordem, você não esquece nenhuma etapa.	2
2	Voltando ao que eu falei antes, em alguns casos o bebê vai precisar do RASC, logo depois do nascimento, que é a atriosseptostomia, para ampliar a comunicação interatrial.	1
2	Voltando ao que eu falei antes, agora vamos diferenciar destroposição de destrocardia. Na dextroposição o coração está deslocado para a direita, mas o ápice continua apontando para a esquerda.	1
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. na destrocardia o próprio ápice aponta para a direita. Então o que define é para onde aponta o ápice.	1
2	Voltando ao que eu falei antes, então a sequência que eu ensino é: primeiro o situs, depois a posição cardíaca, em seguida as conexões venosas, depois as conexões atrioventriculares, e por último as conexões ventriculoar	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: se você seguir sempre essa ordem, você não esquece nenhuma etapa. É o passo a passo da análise sequencial segmentar.	1
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. em alguns casos o bebê vai precisar do RASC logo depois do nascimento, que é a atriosseptostomia, para ampliar a comunicação interatrial.	1
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. observem que isso muda o planejamento do parto, que deve acontecer num centro com cardiologia pediátrica.	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: agora vamos diferenciar destroposição de destrocardia. Na dextroposição o coração está deslocado para a direita, mas o ápice continua apontando para a esqu	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: na destrocardia o próprio ápice aponta para a direita. Então o que define é, para onde aponta o ápice.	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: as causas de dextroposição que, a gente mais vê são hérnia diafragmática e derrame pleural, que empurram o coração.	2
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: então a sequência que eu, ensino é: primeiro o situs, depois a posição cardíaca, em seguida as conexões venosas, depois as conexões atrioventriculares e po	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: se você seguir sempre essa ordem, você não esquece nenhuma etapa. É o passo a passo da análise sequencial segmentar.	1
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. em alguns casos o bebê vai precisar, do RASC logo depois do nascimento, que é a atriosseptostomia, para ampliar a comunicação interatrial.	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: observem que isso muda o planejamento do parto, que deve acontecer num centro com cardiologia pediátrica.	2
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. agora vamos diferenciar destroposição, de destrocardia. Na dextroposição o coração está deslocado para a direita, mas o ápice continua apontando para a esquerda.	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: na destrocardia o próprio ápice aponta para a direita. Então o que define é para onde aponta o ápice.	1
2	Voltando ao que eu falei antes, as causas de dextroposição que a gente mais vê são hérnia diafragmática, e derrame pleural, que empurram o coração.	1

Cap.	Trecho	Repetia o cap.
2	Vejam bem, então a sequência, que eu ensino é: primeiro o situs, depois a posição cardíaca, em seguida as conexões venosas, depois as conexões atrioventriculares e por último as conexões ventriculoarteriais.	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: se você seguir sempre essa ordem, você não esquece nenhuma etapa. É o passo a passo da análise sequencial segmentar.	1
2	Vejam bem, em alguns casos o bebê vai precisar do RASC logo depois do nascimento, que é a atriosseptostomia, para ampliar a comunicação interatrial.	1
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. observem que isso muda o planejamento do parto, que deve acontecer num centro com cardiologia pediátrica.	1
2	Voltando ao que eu falei antes, agora vamos diferenciar destroposição de destrocardia. Na dextroposição o coração, está deslocado para a direita, mas o ápice continua apontando para a esquerda.	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: na destrocardia o próprio ápice aponta para a direita. Então o que define é para onde aponta o ápice.	1
2	Vejam bem, as causas de dextroposição que a gente mais vê são hérnia diafragmática e derrame pleural, que, empurram o coração.	1
2	Voltando ao que eu falei antes, então a sequência que eu ensino é: primeiro o situs, depois a posição, cardíaca, em seguida as conexões venosas, depois as conexões atrioventriculares e por último as conexões ventriculoar	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: se você seguir sempre essa ordem, você não esquece nenhuma etapa. É, o passo a passo da análise sequencial segmentar.	1
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. em alguns casos o bebê vai precisar do RASC logo depois do nascimento, que é a atriosseptostomia, para ampliar a comunicação interatrial.	1
2	Voltando ao que eu falei antes, observem que isso muda o planejamento do parto, que deve acontecer num centro com cardiologia pediátrica.	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: agora vamos diferenciar destroposição de destrocardia. Na dextroposição, o coração está deslocado para a direita, mas o ápice continua apontando para a esq	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: na destrocardia o próprio ápice aponta, para a direita. Então o que define é para onde aponta o ápice.	1
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. as causas de dextroposição que a gente mais vê são hérnia diafragmática e derrame pleural, que empurram o coração.	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: então a sequência que eu ensino é: primeiro o situs, depois a posição cardíaca, em seguida as conexões venosas, depois as conexões atrioventriculares e por	1
2	Voltando ao que eu falei antes, se você seguir sempre essa ordem, você não esquece nenhuma etapa. É, o passo a passo da análise sequencial segmentar.	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: em alguns casos o bebê vai precisar do RASC logo depois do nascimento, que é a, atriosseptostomia, para ampliar a comunicação interatrial.	1
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. observem que isso muda o planejamento do parto, que, deve acontecer num centro com cardiologia pediátrica.	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: agora vamos diferenciar destroposição de, destrocardia. Na dextroposição o coração está deslocado para a direita, mas o ápice continua apontando para a esq	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: na destrocardia o próprio ápice, aponta para a direita. Então o que define é para onde aponta o ápice.	1
2	Vejam bem, as causas de dextroposição que a gente mais vê são hérnia, diafragmática e derrame pleural, que empurram o coração.	1

Cap.	Trecho	Repetia o cap.
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. então a sequência que eu ensino é: primeiro o situs, depois a posição cardíaca, em seguida as conexões venosas, depois as conexões atrioventriculares, e por último as conexões ve	1
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. se você seguir sempre essa ordem, você não esquece nenhuma etapa. É o passo a passo da análise sequencial segmentar.	1
2	Vejam bem, em alguns casos o bebê vai precisar do RASC logo depois do nascimento, que é a atriosseptostomia, para ampliar a comunicação interatrial.	1
2	Repetindo esse ponto com outras palavras para quem chegou agora: observem que isso, muda o planejamento do parto, que deve acontecer num centro com cardiologia pediátrica.	2
2	Alguém perguntou sobre isso no intervalo. agora vamos diferenciar destroposição de destrocardia. Na dextroposição o coração está deslocado para a direita, mas o ápice continua apontando para a esquerda.	1

7. Slides e associação com a fala

“fala” = slide comentado na transcrição; “posição” = não comentado, incluído pela ordem do material; “nenhuma” = não utilizado.

Slide	Título	Cap.	Associação	Figura	Visão
A1-p2	Situs solitus	1	fala		sim
A1-p3		1	posição		sim
A1-p4	Malformações	1	posição		sim
A1-p5	Situs ambíguo e isomerismos	1	fala		sim
A1-p6	Isomerismo esquerdo – ázigos	1	fala	sim	sim
A1-p7	Dextroposição	1	posição	sim	sim
A1-p8	Isomerismos – comparação	1	posição		sim
A2-p2		2	posição		sim
A2-p3	Sequência de avaliação	2	fala		sim
A2-p4	Malformações	2	posição		sim
A2-p5	Atriosseptostomia de Rashkind	2	posição		sim
A2-p6	Isomerismo esquerdo – ázigos	2	posição	sim	sim
A2-p7	Dextroposição	2	fala	sim	sim